



נוהל מס': 024.14
שם הנוהל: ניהול לידה בגבול החיות
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:30.12.14 מהדורה: תאריך עדכון:
	שם הנוהל: ניהול לידה בגבול החיות		
	כותב הנוהל: ד"ר גורלניק , ד"ר טנוס		נספחים: Mortality rate by gestational age
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' זאב וינר	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	
מס' דפים: 7	על החתום:	על החתום:	

תוכן העניינים

2.....	רקע
2.....	מטרת הנוהל:
2.....	הגדרות:
2.....	קווים מנחים כללים בניהול לידה בגבול החיות
4.....	גישה לניהול לידה לפי שבוע ההריון בגבול החיות
4.....	לידה בטווח שבין 22+0 (22 שבועות ו-0 ימים) ו-22+6 (22 שבועות ו-6 ימים)
5.....	לידה בטווח שבין 23+0 (23 שבועות ו-0 ימים) ו-23+6 (23 שבועות ו-6 ימים)
5.....	לידה בטווח שבין 24+0 (24 שבועות ו-0 ימים) ו-24+6 (24 שבועות ו-6 ימים)
6.....	סימוכין (אסמכתאות)
7.....	נספחים:

נוהל מס': 024.14
שם הנוהל: ניהול לידה בגבול החיות
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



ניהול לידה בגבול החיות

רקע

ניהול לידה בגבול החיות הינו נושא מורכב הן מבחינה רפואית והן מבחינה אתית, אשר דורש שיתוף פעולה רב תחומי בין הרופא המיילד, רופא הילדים והצורך בשיתוף ההורים בהסבר ובקבלת ההחלטות. לידה בגבול החיות מהווה פחות מ 1% מכלל הלידות אך אחראית לכ 50% מהתמותה הפרינאטאלית. מתחילת שנות ה 90 קיימת בעולם עלייה בשיעור השרידות של יילודים בגבול החיות כאשר שבוע ההריון ומשקל הלידה הם הגורמים המשמעותיים אשר מנבאים את סיכויי ההישרדות. מנתונים שפורסמו ע"י משרד הבריאות בשנת 2010 עולה שסיכוי השרידות לפי שבוע הריון עומד על 61.8% בשבוע 25, 28.8% בשבוע 24 ו 4.7% בשבוע לידה > 24 שבועות (נספח 1). למרות השיפור בשרידות, כ 50% מיילודים אלה סובלים מתחלואה כרונית. בעולם גבול החיות הוא תחום אפור, אשר ניהולו שונה ממרכז רפואי אחד לאחר, במיוחד מבחינת אינטנסיביות הטיפול ביילוד, דבר, אשר גורם לשונות בשיעורי השרידות הכללית והתחלואה הכרונית המדווחים בין המרכזים השונים.

מטרת הנוהל:

הגדרה וניהול לידה בגבול החיות

הגדרות:

לידה בגבול החיות מוגדרת כסיום הריון בגיל הריון של 22+0 שבועות ומעלה. בהגדרות אחרות מתייחסים גם למשקל העובר הגדול מ-500 גרם. נוהל זה דן בניהול לידות בטווח שבין 22 שב' + 0 ימים ו- 24 שב' ו 6 ימים.

קווים מנחים כללים בניהול לידה בגבול החיות

1. קביעת גיל ההריון:

לקביעת גיל ההריון המדויק חשיבות רבה על צורת ניהול הלידה ולכן יש לקבל אנמנזה מלאה מהיולדת לגבי התאריך המדויק של הוסת האחרון ובדיקות הדמיה אשר בוצעו בהריון. התיעוד המהימן ביותר הוא בדיקת על שמע של העובר בשליש הראשון של ההריון. במידה ולא בוצע, יש להסתמך על בדיקת השקיפות עורפית או בדיקת העל שמע אשר בוצעה בטרימסטר השני (במידה וקיים פער בין גיל ההריון לפי וסת אחרון

- ובדיקת העל-שמע, תיקון לגיל ההיריון ייעשה אם בדיקת העל-שמע אשר בוצעה ב-13 השבועות הראשונים תגלה פער של יותר מ-6 ימים, או אם בדיקת העל-שמע אשר בוצעה בין השבועות 14-20 תגלה פער גדול מ-10 ימים).
2. הערכת היולדת בקבלתה לחדר לידה:
חשוב לשלול גורמים, אשר מסכנים את בריאות היולדת כמו פילונפריטיס, כוריאמניוניטיס או הפרדות שיליה ולכן בקבלת היולדת יש לבצע בדיקה גופנית מלאה, בדיקה גינקולוגית מלאה, חשוב לתעד בין השאר את הפתיחה הצווארית, ירידת מי שפיר, דימום וטיב ההפרשות הנרתיקיות. לפי המצב הקליני יש לקחת ספירת דם, כימיה כולל תפקודי כבד וכליה, תפקודי קרישה, שתן לכללית ותרבית ומשטחים נרתיקיים
3. בדיקת על שמע של העובר:
הבדיקה כוללת מצג, כמות מי שפיר, הערכת משקל ומיקום השיליה. לאור החשיבות של המשקל העוברי על הפרוגנוזה, בדיקה זו תבוצע ע"י רופא בכיר או אחראי תורנות.
4. התפקיד של הטיפול הטוקוליטי:
יש מעט עבודות בספרות אשר בחנו את יעילות הטיפול הטוקוליטי בגבול החיות, מהמידע הקיים לא הודגם יתרון של טיפול זה מבחינת הארכת גיל ההריון או שיפור התוצאות הפרינאטאליות
5. מתן סטרואידים:
בספרות מדווח שמתן סטרואידים בין שבוע 24-28 להריון לא הוריד את הארעות של סיבוכים ראתיים של היילודים אבל כן הייתה ירידה משמעותית בהארעות דימום לתוך חדרי המוח דרגה III ו IV ונכון להיום ההמלצה הקיימת היא לתת טיפול בסטרואידים לנשים עם חשש ללידה מוקדמת החל משבוע 24 להריון.
6. טיפול אנטיביוטי:
המטרה של הטיפול האנטיביוטי היא למנוע אלח דם מוקדם של היילוד ע"י GBS ועל כן יש לתת את הטיפול המקובל במקרים שיש החלטה לתת טיפול תומך מלא ליילוד.
7. טיפול במגנזיום:
אין מספיק מידע בספרות על יעילות הטיפול במגנזיום על הפחתת שיעור שיתוק מוחין ביילוד בגבול בחיות. אם התקבלה החלטה על טיפול אקטיבי ביילוד עד שבוע 24 הטיפול יינתן לפי שיכול דעת. מומלץ לתת טיפול במגנזיום לפי פרוטוקול מחלקתי החל משבוע 24 להריון.

8. ניטור עוברי בזמן לידה:
הניטור העוברי יכול להתבצע באופן רציף או לסירוגין ויכול להתבצע ע"י בדיקת על קול. הניטור יבוצע בהתאם לשבוע ההיריון וכאשר תוצאותיו ישפיעו על ניהול הלידה.
9. ניתוח קיסרי בגבול החיות
רוב המידע הקיים בספרות מבוסס על מחקרים רטרוספקטיביים אשר על פיהם דווח שלניתוח קיסרי אין יתרון בשיפור השרידות או התחלואה הפרינאטאלית של היילוד כולל בעוברים במצג עכוז. ההמלצה היא לבצע ניתוח רק באנדקציה אמהית כמו במקרים של דימום בלתי נשלט או רעלת הריון קשה.
10. רופא ילדים חייב להיות נוכח בכל לידה בשבוע 22 שב' + 0 ימים ו\או צפי למשקל יילוד של $500 \leq$ גרם.
11. החייאת היילוד או קביעת מוות עוברי תבוצע ע"י רופא ילדים בלבד.
משבוע 22 יש לשלוח עובר לבדיקה פתולוגית PM בהסכמת ההורים.

גישה לניהול לידה לפי שבוע ההריון בגבול החיות

- לידה בטווח שבין 22+0 (22 שבועות ו-0 ימים) ו-22+6 (22 שבועות ו-6 ימים)**
1. יש לוודא את גיל ההריון המדויק, מצב היולדת, מצב העובר והמשקל המוערך
 2. הנתונים מהארץ ומהעולם מצביעים על סיכויי שרידות אפסיים של היילוד בגיל זה. יש לתת ולתעד הסבר מפורט להורים על ידי רופא מיילד ו\או רופא ילדים על הפרוגנוזה הגרועה ליילוד בגיל הריון זה.
 3. יש לנהל את הלידה ע"פ התוויות אימהיות בלבד.
 4. אין לתת טיפול טוקוליטי או טיפול בסטרואידים
 5. אין צורך בניטור עוברי במהלך הלידה.
 6. רופא ילדים יהיה נוכח בלידה ולאחריה יקבל את היילוד לידי.

לידה בטווח שבין 23+0 (23 שבועות ו-0 ימים) ו-23+6 (23 שבועות ו-6 ימים)

1. יש לוודא את גיל ההריון המדויק, המשקל המוערך, מצב היולדת ומצב העובר.
2. הנתונים מהארץ ומהעולם מצביעים על שיעור שרידות מוגבל של פחות מעשירית מהילודים וההמלצה היא לנהל את הלידה ע"פ התוויות אימהיות בלבד.
3. יש לתת ולתעד הסבר מפורט להורים על ידי רופא מיילד ו\או רופא ילדים על סיכויי השרידות הנמוכים של היילוד בגיל הריון זה.
4. במקרים בהם קיים ביקוש מפורש מההורים לנהל את הלידה לפי התוויה עוברית ניתן לשקול מתן סטרואידים, מגנזיום וטיפול אנטיביוטי סביב הלידה. במקרים אלה יש לדון עם ההורים על צורת הלידה במידה ותהיה אנדקציה עוברית לניתוח קיסרי ולתעד את זה בכתב תוך כדי הסבר על הסכנות והסיכויים האמהיים של ניתוח קיסרי וההשלכות על הריונות עתידיים לעומת סיכויי השרידות הנמוכים של היילוד.

לידה בטווח שבין 24+0 (24 שבועות ו-0 ימים) ו-24+6 (24 שבועות ו-6 ימים)

1. יש להעריך את גיל ההריון המדויק, המשקל המוערך, מצב היולדת ומצב העובר.
2. הנתונים מהארץ ומהעולם מצביעים על עליה בשרידות בגיל הריון זה. על כן, כדאי להמליץ להורים על ניהול הלידה גם ע"פ התוויה עוברית.
3. הסבר על תמותה ותחלואה בשבוע הריון זה ינתן ע"י רופא מיילד ו\או רופא ילדים.
4. מומלץ לתת טיפול בסטרואידים, טיפול אנטיביוטי וטיפול במגנזיום סביב הלידה.
5. במידה ויוחלט על ניהול לידה בהתוויה עוברית, יש לדון ולתעד את האפשרות של לידה בניתוח קיסרי במידה ותהיה אינדקציה עוברית אשר תחייב דיון זה.

נוהל מס': 024.14
שם הנוהל: ניהול לידה בגבול החיות
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

סימוכין (אסמכתאות)

1. Perinatal management of pregnant women at the threshold of infant viability. Scientific impact paper No.41, February 2014. Royal College of obstetricians & gynecologist
2. Perinatal care at the threshold of viability. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists number 8, September 2002. ACOG practice bulletin
3. נייר עמדה-ניהול לידה בגבול החיות
4. Seri I, Evans J. Limit of viability: definition of gray zone. J Perinat Med 2008.
5. **Carlo WA**, McDonald SA, Fanaroff AA. Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks' gestation. JAMA. **2011** Dec 7;306(21):2348-58

נוהל מס': 024.14
שם הנוהל: ניהול לידה בגבול החיות
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

נספחים:

נספח 1.

